



Périmètre limité : le référentiel SFAR complet (2009-2011) comporte 4 modules (Cardiovasculaire, Douleur chronique/toxicomanie et Neurologique-psychiatrique/phytothérapie, traités dans des fiches séparées). Cette fiche couvre le Module 3 — anti-infectieux, immunosuppresseurs.

C

AF

Grille ANAES 2004 — seuls deux grades apparaissent effectivement dans ce module : **C** : faible niveau de preuve ; **AF** : accord fort (grade D renforcé par méthode Delphi, même convention que les Modules 1 et 2). Fiche limitée au Module 3/4 du référentiel (anti-infectieux, immunosuppresseurs) — voir encadré de périmètre ci-dessous.

Antituberculeux

Classe	Recommandation	Grade
Antituberculeux	Poursuivre le traitement instauré aux mêmes posologies et par voie orale, ainsi que la supplémentation vitaminique associée (B1 et B6).	AF
Antituberculeux	En cas de nécessité d'interruption prolongée du traitement, une prise en charge pluridisciplinaire est recommandée.	AF

Précision du source : isoniazide/rifampicine/thioamides favorisent une toxicité hépatique ; la rifampicine est inductrice enzymatique (majorer de 30-50% la posologie des corticoïdes associés) et peut provoquer une thrombopénie (à écarter avant chirurgie) ; aminosides potentiellement néphrotoxiques (monitorage rénal) ; surveillance glycémique sous thioamides. Agents anesthésiques : thiopental proscrit (induction enzymatique majeure l'hépatotoxicité) ; halothane et enflurane contre-indiqués ; propofol, isoflurane, desflurane et sévoflurane utilisables raisonnablement avec surveillance hépatique rapprochée. Curares : mivacurium/atracurium/cisatracurium indiqués si atteinte hépatique (métabolisme indépendant) ; prudence si traitement par aminoside (potentialisation du bloc). Isolement respiratoire obligatoire si traitement < 15 jours (circulaire DGS/VS-DH n° 69 du 29/10/1993) ; BK tubage en urgence au-delà. Éviter les fortes doses de paracétamol. Relais IV possible pour isoniazide, éthambutol et rifampicine uniquement ; avis spécialisé indispensable pour les autres molécules (guidé par l'antibiogramme). Adaptations posologiques en cas d'insuffisance rénale (clairance < 30 ml/min) et de toxicité hépatique (paliers selon les transaminases) détaillées dans le texte source.

Antirétroviraux

Classe	Recommandation	Grade
Antirétroviraux	En raison de l'importance de l'observance, les arrêts de traitement doivent être évités en période périopératoire.	AF
Antirétroviraux	Toute interruption non évitable (jeûne préopératoire) sera la plus courte possible, au plus 48 heures maximum.	AF
Antirétroviraux	En cas d'arrêt, tous les antirétroviraux doivent être interrompus et repris simultanément (éviter une monothérapie, source de résistance virale).	AF
Antirétroviraux	Tout arrêt de traitement doit faire l'objet d'un avis spécialisé.	AF

Précision du source : les inhibiteurs de protéase (IP) nécessitent une prise alimentaire concomitante, incompatible avec le jeûne préopératoire. Rifampicine contre-indiquée avec les IP non associés au ritonavir (monitorage thérapeutique obligatoire si nécessité impérative). Risque d'activation d'une hépatite B chronique à l'arrêt prolongé d'un antirétroviral actif sur ce virus (lamivudine, ténofovir, emtricitabine). Interactions via les cytochromes P450 (CYP2B6, CYP3A4) avec de nombreux médicaments d'anesthésie ; midazolam potentiellement majoré (dépression respiratoire, somnolence). Neuropathie sous INTI (ex. didanosine) à prendre en compte pour l'ALR périnerveuse. En réanimation prolongée : monitoring thérapeutique nécessaire (absence de forme injectable pour la plupart des molécules, altération de l'absorption digestive).



Inhibiteurs de calcineurine (ciclosporine, tacrolimus)

Classe	Recommandation	Grade
Inhib. calcineurine	La poursuite de l'immunosuppression peut s'accompagner d'un risque plus élevé d'infections postopératoires.	C
Inhib. calcineurine	Monitoring indispensable (et possible diminution des doses) des curares non dépolarisants — la ciclosporine peut augmenter l'intensité et la durée de la curarisation.	C
Inhib. calcineurine	Le midazolam et la lidocaïne diminueraient le métabolisme du tacrolimus.	C
Inhib. calcineurine	De grandes modifications des taux sanguins sont possibles en cas de remplissage massif périopératoire ou de circulation extracorporelle.	C
Inhib. calcineurine	Surveiller les taux plasmatiques et la fonction rénale en concertation avec le spécialiste en charge de l'immunosuppression du patient.	AF
Inhib. calcineurine	La reprise précoce du traitement est nécessaire (voie orale ou intraveineuse selon la situation).	AF
Inhib. calcineurine	Si la voie entérale est compromise, il est possible d'administrer le traitement par voie intraveineuse.	C

Précision du source : ne pas donner la ciclosporine le matin de l'intervention en cas d'AG (le tacrolimus peut être poursuivi par voie sublinguale) ; éviter les AINS (potentiel néphrotoxique en association) ; monitoring des taux indispensable quelle que soit la technique d'anesthésie (C2 pour la ciclosporine, taux résiduel pour le tacrolimus).

Thalidomide

Classe	Recommandation	Grade
Thalidomide	Ne pas interrompre la thalidomide, en tenant compte de la fréquence des neuropathies et du risque de maladie thromboembolique veineuse.	AF

Précision du source : évaluation précise d'une éventuelle neuropathie périphérique avant toute ALR (touche en particulier les nerfs saphènes externes et médians, peut persister après l'arrêt) ; prévention efficace du risque thromboembolique veineux périopératoire.

Méthotrexate

Classe	Recommandation	Grade
Méthotrexate	Une toxicité médullaire et muqueuse est fortement suspectée en présence de protoxyde d'azote.	C
Méthotrexate	Les AINS sont contre-indiqués pour l'analgésie (potentialisation de la toxicité hématologique et rénale).	C
Méthotrexate	Ne pas interrompre le traitement, en tenant compte de la toxicité hématologique et rénale, en particulier en association avec le protoxyde d'azote ou les AINS en périopératoire.	AF
Méthotrexate	En cas de maintien ou de reprise précoce, il est conseillé de ne pas utiliser de protoxyde d'azote durant l'anesthésie.	C

Azathioprine

Classe	Recommandation	Grade
Azathioprine	Le taux d'infection postopératoire après induction de l'immunosuppression pour transplantation n'est pas élevé.	C
Azathioprine	Dans le contexte de la chirurgie colique, le maintien n'est pas associé à un risque accru de complications postopératoires.	C
Azathioprine	La posologie de curare semble pouvoir être identique à celle utilisée chez le sujet sain, malgré une diminution de leur effet par l'azathioprine.	C



Classe	Recommandation	Grade
Azathioprine	Administrer le traitement avec la prémédication.	AF
Azathioprine	En cas d'interruption prolongée, se concerter avec le spécialiste prenant en charge le patient pour ce traitement.	AF

Mycophénolate mofétil

Classe	Recommandation	Grade
Mycophénolate	Administrer le traitement avec la prémédication.	AF
Mycophénolate	En cas d'interruption prolongée, se concerter avec le spécialiste prenant en charge le patient pour ce traitement.	AF
Mycophénolate	Il n'y a pas d'intérêt au dosage de la molécule pour le suivi thérapeutique ou l'adaptation posologique.	C

Cyclophosphamide

Classe	Recommandation	Grade
Cyclophosphamide	L'effet des curares dépolarisants peut être prolongé chez les patients ayant reçu du cyclophosphamide, même à distance de la prise.	C
Cyclophosphamide	Administrer le traitement avec la prémédication.	AF
Cyclophosphamide	En cas d'interruption prolongée, se concerter avec le spécialiste prenant en charge le patient pour ce traitement.	AF

Anticorps monoclonaux anti-TNF (infliximab, adalimumab, étanercept)

Classe	Recommandation	Grade
Anti-TNF	Dans le contexte de la chirurgie colique (maladie de Crohn ou RCH), le traitement n'est pas associé à un risque accru de complications postopératoires et pourra être poursuivi.	C

Précision du source : compte tenu du risque potentiel de sepsis et de la demi-vie longue de ces traitements, il est conseillé de les arrêter une semaine avant une chirurgie programmée (hors contexte Crohn/RCH ci-dessus) ; reprise possible la semaine suivant l'intervention en l'absence de complication.

Sources et avertissement

Document source : Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR), « Gestion périopératoire des traitements chroniques et dispositifs médicaux — Anti-infectieux, immunosuppresseurs », Recommandations Formalisées d'Experts, Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 28 (2009) 1057-1065.

URL source : <https://sfar.org/gestion-perioperatoire-des-traitements-chroniques-et-dispositifs-medicaux-anti-infectieux-immunosuppresseurs/>

Couverture : Module 3/4 du référentiel uniquement (anti-infectieux, immunosuppresseurs) — 30 lignes de recommandations gradées (accord fort:16, grade C:14 ; consolidation de 3 citations de même grade sur le même scénario clinique dans le module anti-TNF, dont une phrase source dupliquée mot pour mot). Ce module achève la couverture des 4 modules effectivement présents dans le PDF fusionné de ce référentiel (Cardiovasculaire, Douleur chronique/toxicomanie et Neurologique-psychiatrique/phytothérapie, traités dans des fiches séparées). Argumentaire scientifique détaillé (document source complet) non reproduit.

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante et PARTIELLE (Module 3 uniquement). Elle ne remplace pas le texte intégral. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la SFAR.